

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 858

SEGUNDO INFORME POSITIVO

8 de junio de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del **Proyecto del Senado 858**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El **Proyecto del Senado 858** propone establecer la “Ley para la Supervisión sobre Medicamentos Compuestos de Alto Riesgo”; requerir la publicación de informes bianuales por parte de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS), y la Junta Examinadora de Farmacia sobre la supervisión de las prácticas de preparación de medicamentos compuestos; garantizar una mayor visibilidad sobre las acciones regulatorias para proteger a los pacientes de medicamentos preparados ilegalmente; y otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Según desprende de la Exposición de Motivos de la medida, la preparación ilegal de medicamentos compuestos representa un desafío creciente y de gran magnitud en Puerto Rico, que pone en riesgo la seguridad de los pacientes y la integridad del sistema de salud. Los ciudadanos merecen medicamentos en los que puedan confiar, que sean seguros, efectivos y elaborados conforme a los más altos estándares de calidad establecidos por las regulaciones estatales y federales. Sin embargo, en los últimos años,

se ha observado un aumento alarmante en la distribución de medicamentos compuestos sin la supervisión adecuada, lo que constituye una amenaza significativa para la salud pública. Este problema es particularmente pronunciado en el caso de los medicamentos GLP-1 utilizados para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, aunque se extiende a otras clases de medicamentos, afectando a diversos sectores de la población.

La preparación de medicamentos compuestos, cuando se realiza conforme a las normativas, es una práctica esencial que permite adaptar tratamientos a las necesidades específicas de los pacientes. No obstante, la proliferación de actividades de preparación ilegal, especialmente en entornos no regulados como spas médicos y clínicas de bienestar, ha generado un vacío en la supervisión de los entes reguladores. Estos establecimientos, que a menudo operan sin la fiscalización de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (en adelante, SARAFS) y la Junta Examinadora de Farmacia en materia de medicamentos, representan puntos ciegos regulatorios. Los actores malintencionados aprovechan estas lagunas legales y de cumplimiento para producir y comercializar medicamentos no aprobados a una escala sin precedentes, exponiendo a los pacientes a riesgos graves, como la administración de productos ineficaces, contaminados o potencialmente peligrosos.

La falta de transparencia sobre las acciones que los reguladores están tomando para abordar este problema agrava la situación. Actualmente, tanto los legisladores como el público general carecen de información clara y detallada sobre las medidas adoptadas por SARAFS y la Junta Examinadora de Farmacia para garantizar que la preparación de medicamentos se realice de manera segura y legal. Esta opacidad dificulta la evaluación de la efectividad de las políticas existentes y la identificación de las áreas donde se necesitan recursos adicionales o reformas regulatorias. Por ejemplo, no se conoce con precisión el número de inspecciones realizadas a instalaciones que manejan medicamentos preparados, ni la naturaleza de las violaciones detectadas, ni las acciones disciplinarias tomadas contra los infractores. Esta falta de datos también limita la capacidad de los responsables de crear políticas para diseñar estrategias que protejan eficazmente a los pacientes.

Además, el aumento en la comercialización de medicamentos preparados a través de prácticas engañosas, como la publicidad indebida en plataformas de telemedicina o telesalud, añade otra capa de complejidad al problema. Estas prácticas no solo confunden a los consumidores, sino que también socavan la confianza en el sistema de salud y en los

profesionales que operan dentro de los marcos regulatorios establecidos. La ausencia de una coordinación efectiva entre las juntas reguladoras y otras agencias estatales, contribuye a la persistencia de estas actividades ilícitas.

Esta Ley busca abordar estas deficiencias al establecer un mecanismo robusto de rendición de cuentas y transparencia. Mediante la exigencia de informes bianuales, se proporcionará a los legisladores, reguladores y al público una visión clara de las actividades de supervisión relacionadas con la preparación de medicamentos. Estos informes incluirán datos críticos sobre licencias emitidas, inspecciones realizadas, investigaciones abiertas, acciones disciplinarias tomadas y riesgos emergentes. Al hacerlo, la Ley no solo promoverá una mayor visibilidad sobre las acciones regulatorias, sino que también permitirá identificar las necesidades de recursos humanos y materiales de las juntas reguladoras, garantizando que estén adecuadamente equipadas para enfrentar los desafíos de la preparación de medicamentos de alto riesgo.

En última instancia, esta legislación tiene como objetivo fortalecer la protección de los pacientes puertorriqueños, asegurando que los medicamentos que reciben sean seguros, efectivos y elaborados bajo estrictos estándares de calidad. Al fomentar una supervisión más efectiva y coordinada entre la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud y la Junta Examinadora de Farmacia, esta Ley representa un paso crucial hacia la mitigación de los riesgos asociados con la preparación ilegal de medicamentos y la restauración de la confianza pública en el sistema de salud.

ALCANCE DEL INFORME

Como parte del proceso de análisis y evaluación del **P. del S. 858**, la Honorable Comisión de Salud del Senado solicitó los comentarios sobre la medida a diversos componentes gubernamentales y no gubernamentales. Los memoriales recibidos y utilizados para el análisis de esta pieza legislativa son: el Departamento de Salud, el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico, Eli Lilly and Company, la Asociación de la Industria Farmacéutica (PIA), la Asociación Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico (AFCPR) COOPHARMA, Industry University Research Center, Inc. (INDUNIV), Biotechnology Innovation Organization (BIO), National Consumers League, American Board of Obesity Medicine, The Partnership for Safe Medicine, el Lcdo. Edwin León Pérez, el Ing. Homar Torres y el Lcdo. Iván Ramírez Macaya.

Igualmente, se solicitaron los comentarios del Departamento de Justicia, no obstante, al momento de redactar este Informe, estos no han remitido los mismos.

Con el propósito de ampliar el análisis y discusión de la pieza legislativa objeto de evaluación, esta Comisión celebró una Vista Pública el pasado 17 de marzo de 2026 sobre el P. del S. 858 a la cual comparecieron los siguientes deponentes: el Departamento de Salud, el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico, la Asociación de la Industria Farmacéutica (PIA) y Eli Lilly and Company.

A continuación, presentaremos un resumen de los argumentos y comentarios esbozados por las diferentes agencias y entidades consultadas durante el proceso de evaluación de la medida en referencia.

DEPARTAMENTO DE SALUD (DS)

El **Departamento de Salud** compareció ante la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico mediante su Memorial Explicativo suscrito por conducto de su Secretario, Dr. Victor M. Ramos Otero, contando con los comentarios de la “Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública” (SARSP). Al exponer su evaluación institucional, operacional y fiscal del Proyecto del Senado Núm.858, la Agencia, inicialmente se expresó en contra de la aprobación de la medida. Aunque reconoció que el fin de la medida es legítimo al buscar mayor transparencia y protección ante la proliferación de medicamentos compuestos ilegales, sostuvo que la pieza legislativa presenta deficiencias estructurales, legales y prácticas que hacen inviable su implementación bajo el marco regulatorio vigente.

La principal objeción del Departamento radica en una inconsistencia jurisdiccional, toda vez que el proyecto pretende que la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) y la Junta Examinadora de Farmacia supervisen e informen sobre establecimientos como "spas médicos", centros estéticos y clínicas de bienestar. Sin embargo, la Agencia aclaró que estas entidades no son facilidades de salud licenciadas ni reguladas por ellos, por lo que carecen de la autoridad legal y de los recursos para realizar inspecciones, recopilar estadísticas o imponer acciones disciplinarias sobre estos "puntos ciegos" del sistema.

Asimismo, identificó como deficiencia técnica crítica que el proyecto no contenga una definición de qué constituye un medicamento compuesto "de alto riesgo". Señaló, que la medida no distingue entre compuestos convencionales y aquellos que, por su potencia o vía de administración, representan un peligro real. Además, advirtió que el Proyecto ignora las definiciones ya establecidas en la Ley de Farmacia (Ley 247-2004) y el Reglamento 156, lo que genera una ambigüedad normativa que dificultaría cualquier esfuerzo de fiscalización.

Otro punto de preocupación traído por la Agencia es la falta de impacto fiscal y administrativo. A tales fines enfatizó, que la preparación de informes bianuales detallados, que incluirían auditorías y conciliación de datos, conllevará costos sustanciales que no han sido presupuestados. Alertó, que imponer estas nuevas cargas sin asignar recursos adicionales podría comprometer las funciones esenciales de fiscalización que ya realizan sobre las farmacias y establecimientos debidamente licenciados.

En cuanto al envío de medicamentos por correo, el Departamento de Salud aclaró que la Ley 247-2004 excluye explícitamente la regulación del mercadeo desde los Estados Unidos o el extranjero hacia Puerto Rico. Por lo tanto, enfatizó, actualmente no tener competencia para fiscalizar los envíos de medicamentos preparados mediante composición que llegan por correo, y denunció que el Proyecto no amplía formalmente estas facultades de manera que puedan ser ejecutadas efectivamente.

En síntesis, resaltó que, aunque el P. del S. 858 persigue fines legítimos de transparencia y protección de la salud pública, también presenta deficiencias estructurales importantes, tales como:

- carece de definiciones esenciales,
- impone deberes a Agencias sin autoridad sobre ciertos establecimientos,
- no se articula adecuadamente con la Ley 247-2004 ni con sus entidades reguladoras,
- omite toda consideración sobre los costos administrativos inherentes a la obligación de producir informes semestrales.

El Departamento de Salud es de la opinión que estas lagunas podrían limitar la eficacia práctica del proyecto y dificultar su implementación bajo el marco regulatorio existente. Además, de que planteó que cualquier legislación relacionada con la manufactura,

distribución y dispensación de medicamentos preparados mediante composición debe ser realizada mediante enmienda a la Ley 247-2004 y no a través de una ley independiente que cree duplicidad o conflictos con el marco legal existente. Es por esto, que no endosó el Proyecto del Senado 858, según redactado de manera original.

Posición del Departamento de Salud sobre el Borrador de Entirillado Electrónico entregado durante la Vista Pública y Contestación al Requerimiento de Información

Según se detallará más adelante, durante la Vista Pública celebrada sobre la medida, el Presidente de la Comisión le requirió al Departamento de Salud presentar un Memorial Suplementario exponiendo su posición en cuanto a las propuestas presentadas en el Borrador de Entirillado Electrónico sobre el P. del S. 858 presentado por Eli Lily del cual se le brindó copia. Asimismo, se solicitó detallar cuál es la Oficina o División de la Agencia que cuenta con la pericia, el personal y la cualificación necesaria para evaluar los datos recopilados tras la aprobación de la propuesta legislativa.

Atendiendo dicha petición, el Departamento de Salud, por conducto de su Secretario, el Dr. Víctor Ramos Otero indicó haber evaluado el mencionado documento junto a las funcionarias de la Sección de Licenciamiento de Farmacias, Medicamentos y Registro de Medicamentos, adscrita a la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) del Departamento.

En síntesis, destacó que la Ley 247-2004, según enmendada, establece el marco regulatorio para la fabricación, distribución, dispensación y uso de medicamentos y productos farmacéuticos en Puerto Rico. Sostuvo, que la implementación de esta Ley se lleva a cabo a través de la Sección de Licenciamiento de Farmacias y Medicamentos de la SARSP, la cual se encarga de regular, licenciar y supervisar los establecimientos que fabrican y distribuyen medicamentos, así como de velar por el cumplimiento de la normativa relacionada con dichas actividades.

En cuanto al texto propuesto, expresó, que resulta compatible y complementario con el marco regulatorio dispuesto por la Ley 247-2004, *supra*. No obstante, en cuanto a la creación de la “Ley para la Supervisión sobre Medicamentos Compuestos de Alto Riesgo” propuesta, es de la opinión que cualquier legislación relacionada con la manufactura, distribución y dispensación de medicamentos preparados mediante composición debe incorporarse mediante enmiendas a la Ley 247-2004, *supra*. Por tanto, recomendó eliminar

del “Entirillado” propuesto las secciones 1, 2 y 3, e incluir lo que corresponda dentro del lenguaje propuesto para la Ley 247-2004 en las secciones subsiguientes, de manera que se evite duplicidad y, por consiguiente, posibles confusiones.

Además, el Departamento de Salud realizó las siguientes recomendaciones centradas en armonizar la medida con la legalidad vigente, corregir errores técnicos y delimitar claramente las jurisdicciones estatales, las cuales resumimos a continuación:

- Ajustes Jurisdiccionales y Legales: El Departamento aclaró que carece de facultad para inspeccionar farmacias fuera de Puerto Rico, por lo que solicitó enmendar el lenguaje que sugiere supervisión directa a farmacias no residentes. Asimismo, sugirió eliminar el inciso sobre publicidad engañosa, ya que esa competencia le pertenece al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y no al Departamento de Salud.
- Integración con la Ley de Farmacia: Recomendó que la Sección 9 del Proyecto no sea una disposición independiente, sino que se redacte como una enmienda directa a la Ley 247-2004 (Ley de Farmacia). Además, reiteró que cualquier nuevo requisito para la preparación de medicamentos debe cumplir estrictamente con los estándares ya establecidos en dicha Ley.
- Claridad en las Licencias y Registros: Propuso un lenguaje más flexible y general para la revocación de licencias, permitiendo que la sanción alcance no solo permisos estándar, sino también autorizaciones especiales y certificaciones de la SARSP. También solicitó precisión terminológica, como el uso correcto de "Certificado de Registro" en lugar de solo "registro".
- Responsabilidad del Farmacéutico: Sobre el requisito de designar a un farmacéutico responsable para pacientes en la Isla, el Departamento solicitó definir claramente su rol. Recomendó, que este cargo tenga un alto nivel de responsabilidad y que se prohíba que un mismo farmacéutico sea designado para más de una farmacia no residente simultáneamente.
- Correcciones Técnicas: Además, identificó varios errores gramaticales y de forma en el borrador de Entirillado Electrónico.

Finalmente, en atención a la solicitud de la Comisión para detallar cuál es la Oficina o División de la Agencia que cuenta con la pericia, el personal y la cualificación necesaria para evaluar los datos recopilados tras la aprobación de esta pieza legislativa, especificó que la Oficina de Planificación y Desarrollo (OPD) constituye la unidad del Departamento de Salud encargada de servir como ente asesor y coordinador estratégico

en apoyo a la gestión del Secretario y de las distintas unidades programáticas. Todo el personal de la Agencia que ejerce funciones de planificación estratégica, evaluación, equidad en salud, análisis de datos u otras funciones similares coordina sus esfuerzos de forma integrada con la OPD.

Enumeró las funciones esenciales que desempeña la Oficina de Planificación y Desarrollo (OPD):

- Servir de instrumento institucional de apoyo a los distintos niveles gerenciales del DS para facilitar la toma de decisiones y viabilizar el cumplimiento de la misión y prioridades del DS en forma eficaz y productiva.
- Contribuir al desarrollo de política pública que atienda de forma efectiva las prioridades de salud pública en Puerto Rico, basada en evidencia y mejores prácticas, para propiciar resultados que incidan positivamente en la salud y el bienestar de la población.
- Abordar las disparidades en salud y promover la equidad y la justicia social hacia las poblaciones de mayor riesgo, vulnerables y las personas que viven en comunidades rurales para mejorar el acceso a los servicios de salud primaria.
- Determinar necesidades y prioridades, y desarrollar y promover estrategias para mejorar la salud pública.
- Estudiar y analizar políticas en salud pública, tanto vigente, propuesta o potencial, mediante la utilización de metodología científica para atender las situaciones u oportunidades presentes en el sistema de salud y proponer recomendaciones que redunden en una utilización eficiente de los recursos disponibles, mayor eficacia y una mejora tangible en los indicadores de salud.
- Formular planes a corto, mediano y largo plazo alineados con las prioridades estratégicas de la Agencia.
- Evaluar y monitorear la calidad de los servicios de salud.
- Viabilizar la evaluación y monitoreo del desempeño de los programas del DS, siempre alineado con las prioridades estratégicas de la Agencia.
- Participar, en coordinación con la Oficina de Gerencia Fiscal, en el desarrollo del presupuesto y las peticiones presupuestarias del DS para asegurar que armonicen con los planes preparados.
- Coordinar el proceso de acreditación y reacreditación de salud pública del DS.

- Coordinar e integrar los esfuerzos del DS para la recopilación, análisis, consumo y disseminación de datos e informes estadísticos de salud pública.

Además, acentuó que la OPD cuenta con la División de Análisis y Publicación Estadística la cual provee, a través de los diferentes datos que se recogen en la Agencia, el análisis estadístico necesario para fundamentar el establecimiento de las condiciones de morbilidad y mortalidad de la población, y facilitar así el establecimiento de política pública sobre salud, desarrollo de investigaciones científicas y el proceso de toma de decisiones en la planificación e implantación de los servicios de salud a la población.

A la luz de lo anterior, y en respuesta a la solicitud de la Comisión de Salud, el Departamento de Salud afirmó que la OPD posee la pericia, el personal y la cualificación necesaria para evaluar los datos recopilados durante la implementación de esta medida. Para concluir, expresó su endoso a la propuesta contenida en el Entirillado Electrónico del Proyecto del Senado 858 propuesto, siempre y cuando se incorporen las enmiendas presentadas en este memorial explicativo enmendado.

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE PUERTO RICO

Esta Ilustre Comisión tuvo la oportunidad de examinar los comentarios presentados por el **Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico** quien presentó su Memorial Explicativo por conducto de su Presidenta, Lcda. Paula Dolores Espada, expresándose a favor de la aprobación de la medida, sujeto a que se acojan sus recomendaciones. Detalló haber sido creado al amparo de la Ley Núm. 243 de 15 de mayo de 1938 con el fin primordial de velar por la excelencia en el ejercicio de la farmacia y la protección de la salud del pueblo.

El Colegio resaltó que esta Comisión se encuentra evaluando simultáneamente el P. del S. 971, cuyo memorial se complementa con el P. del S. 858, ya que ambas piezas abordan desafíos similares y críticos relacionados con la proliferación de modelos de negocio que impactan directamente la cadena de manejo de medicamentos, la seguridad en la composición de fármacos y la protección de la salud pública. Indicó, que su posición emana de un mandato democrático de su matrícula bajo la Resolución Núm. 2025-01, aprobada por unanimidad en octubre de 2025, la cual ordena fiscalizar cualquier iniciativa que pueda precarizar la cadena de custodia de medicamentos en Puerto Rico.

El Colegio expresó su respaldo firme a la intención de supervisar los medicamentos compuestos de alto riesgo; sin embargo, manifestó su oposición tajante a la definición de “Spa Médico o Clínica de Bienestar” contenida en el Artículo 3(e), al entender que dicha redacción pretende conceptualizar estos lugares como centros facultados para la “dispensación” de medicamentos preparados, lo cual representaría una normalización de una ilegalidad y un riesgo extremo para el ordenamiento jurídico de la salud.

Planteó que, bajo la Ley de Farmacia de Puerto Rico la dispensación es un acto clínico exclusivo del farmacéutico licenciado. Acentuó que, con la con la única excepción del manejo de muestras de medicamentos por médicos autorizados, ningún otro profesional está facultado para despachar fármacos a pacientes. Más aún, especificó que actuar en contrario constituiría un delito. Alertó, que incluir el término “dispensación” como parte de la definición en el Proyecto podría generar una ambigüedad que estos negocios podrían invocar como un subterfugio para eludir la regulación, pretendiendo el amparo de una categoría ficticia inexistente en nuestro derecho positivo.

El colegio sostuvo que la preparación de sustancias, ya sean cocteles de vitaminas o péptidos para el manejo de peso (GLP-1), constituye composición estéril de alto riesgo (*compounding*). Considera como una omisión técnica grave que el P. del S. 858 guarde silencio sobre los estándares técnicos mínimos. Sobre esto, resaltó, que según el Artículo 2.18 de la Ley 247-2004, las normas de la Farmacopea de los Estados Unidos son de aplicación obligatoria.

La institución solicitó que cualquier entidad que realice estas preparaciones cuente con la infraestructura de cuartos-limpios (*clean rooms*), campanas de flujo laminar y sistemas de filtración HEPA correspondientes. Además, es de la opinión que, sin la exigencia explícita de estos estándares y de las licencias de manufactura que cumplan con la FDA, los informes bianuales propuestos solo servirán para documentar estadísticamente la existencia de productos elaborados en ambientes potencialmente no controlados, donde un error microbiológico puede resultar en sepsis, meningitis fúngica o incluso la muerte del paciente.

De otra parte, sugirió que la pieza legislativa reconozca la distinción federal bajo la *FD&C Act* entre farmacias tradicionales (503A) e instalaciones de manufactura externa (503B). Añadió, que cualquier establecimiento que realice compuestos sin una receta individualizada debe cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura actuales (cGMP).

Además, denunció que el despacho de jeringuillas fuera del entorno supervisado viola el *Drug Supply Chain Security Act* (DSCSA), al carecer de controles de trazabilidad federal que impidan la entrada de productos falsificados o de procedencia dudosa al sistema de suministro nacional.

Para que esta legislación sea efectiva, propuso requerir al Departamento de Salud un inventario detallado de las licencias emitidas a establecimientos no-farmacéuticos y que se certifiquen los protocolos de inspección utilizados. Sobre el particular, expuso que, al presente, existe incertidumbre sobre si la Agencia cuenta con el personal capacitado para fiscalizar el cumplimiento con la Sección 503B y el DSCSA en estas facilidades.

Puntualizó el Colegio que, el compromiso del Estado con la seguridad de los medicamentos debe ser absoluto. Por lo tanto, el Colegio fue enfático en que su aval al P. del S. 858 está condicionado a la eliminación del término “dispensación” de las definiciones y a la incorporación de los estándares técnicos federales y estatales aquí expuestos. Reveló, que su prioridad es detener de inmediato la operación de “dispensarios de facto” que ponen en riesgo la vida humana.

En conclusión, el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico endosó la intención del Proyecto del Senado 858 como una medida necesaria para arrojar luz sobre un problema creciente y peligroso. Sin embargo, destacó que el compromiso del Estado con la seguridad de los medicamentos y la vida de los ciudadanos debe ser absoluto por lo que recalcó que no se puede permitir que la innovación en los servicios de bienestar se convierta en un pretexto para eludir las normas cardinales de seguridad (estatales y federales) en la composición y dispensación de fármacos que han costado décadas establecer. Señaló, que el cumplimiento con la distinción federal entre las secciones 503A y 503B del FD&C Act, los estándares de manufactura cGMP y las exigencias de trazabilidad del DSCSA no son opcionales, sino que son la única garantía de que los pacientes en Puerto Rico no reciban productos subestándares o peligrosos.

Finalmente requirió que la Comisión acoja la petición de investigación formulada y las enmiendas propuestas, especialmente la eliminación de cualquier lenguaje que sugiera que un centro de bienestar puede “dispensar” medicamentos y la incorporación de los estándares USP como requisito *sine qua non* para cualquier operación de composición.

ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA (PIA)

Esta Ilustre Comisión recibió los comentarios de la **Asociación de la Industria Farmacéutica de Puerto Rico (PIA)** suscritos por su Líder de Operaciones, Jose Juan Marrero, expresando su firme apoyo al Proyecto del Senado 858. Argumentó, que el mismo es esencial para salvaguardar la salud de los pacientes frente a los riesgos de los medicamentos compuestos de manera inadecuada.

Para la organización, esta legislación representa una herramienta vital para combatir la proliferación de medicamentos compuestos producidos en masa que, a diferencia de los fármacos tradicionales aprobados por la FDA, no suelen someterse a revisiones previas de seguridad, calidad o eficacia. PIA destacó con preocupación que los pacientes que utilizan estos productos sin la debida regulación tienen el doble de probabilidades de enfrentar hospitalizaciones, por lo que ven en este proyecto una defensa necesaria para que la composición de medicamentos sea una práctica excepcional y estrictamente controlada, limitada a casos de necesidad clínica real como las alergias a componentes específicos.

En cuanto a la integridad técnica de los fármacos, la posición de PIA se extendió a la supervisión rigurosa de los ingredientes farmacéuticos activos (API). Sostuvo, que no basta con regular el lugar de preparación, sino que es imperativo certificar el origen de cada componente. Acentuó que, al exigir que cada API cuente con documentación que detalle su identidad, pureza y cumplimiento con monografías de medicamentos aplicables e informe sobre cualquier impureza, o mediante pruebas farmacéuticas opcionales si la documentación del proveedor es insuficiente, el Proyecto minimiza el riesgo de que entren ingredientes ilícitos o subestándar en la cadena de suministro. Para PIA, el hecho de que las farmacias deban verificar por escrito que sus proveedores están registrados ante la FDA y libres de alertas de importación es un paso adelante en la competitividad global de la industria biofarmacéutica local, elevando el estándar de lo que se dispensa en las farmacias puertorriqueñas.

Además, PIA subrayó que el P. del S. 858 resuelve un vacío jurídico histórico al imponer controles estrictos sobre las farmacias no residentes que operan fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. La organización considera acertado que cualquier entidad que envíe medicamentos a la Isla, sin importar su ubicación geográfica, esté sujeta a un marco de registro y rendición de cuentas que incluya la notificación de eventos adversos y el

cumplimiento de licencias. Afirmó que, al vincular el registro de estas farmacias con la capacidad de reembolso de las aseguradoras y el uso por parte de proveedores médicos, la Ley crea un mecanismo de cumplimiento efectivo que protege al consumidor. Finalmente, PIA considera que esta medida una oportunidad para que el Departamento de Salud y la SARSP lideren un proceso de fiscalización proactiva, garantizando que el acceso a medicamentos no se vea comprometido por prácticas de distribución no reguladas o inseguras.

ELI LILY AND COMPANY

Eli Lilly and Company compareció ante la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico mediante memorial explicativo, por conducto de su Vice-Presidente, Brad Jordan expresándose a favor de la aprobación del proyecto con las enmiendas propuestas en un Borrador de Entirillado Electrónico que fue adjunto y evaluado en la Vista Pública celebrada.

Eli Lilly and Company fundamentó su apoyo al Proyecto del Senado 858 en la urgencia de establecer un marco regulatorio robusto y vinculante que proteja a los pacientes en Puerto Rico de los riesgos críticos asociados a los medicamentos compuestos de alto riesgo. La empresa advirtió que, a diferencia de los fármacos manufacturados por la industria biotecnológica tradicional, los productos compuestos no atraviesan el riguroso proceso de aprobación previa de la FDA, lo que ha facilitado una tendencia preocupante donde ciertos proveedores producen medicamentos en masa utilizando ingredientes farmacéuticos activos (API) de calidad inferior, a menudo provenientes de China y otras fuentes extranjeras sin supervisión. Subrayó que esta práctica no es un riesgo hipotético, incluso, citó datos de la FDA donde se han detectado contaminaciones bacterianas, niveles significativos de impurezas en mezclas de péptidos como el tirzepatide y una tasa de hospitalización por eventos adversos que duplica la de los medicamentos aprobados.

Denunció, además, que la producción en masa de medicamentos compuestos por parte de suplidores que ignoran la Ley, utilizando API, carecen de aprobación previa (*pre-market approval*) y pruebas clínicas, lo que expone a los pacientes a riesgos significativos como concentraciones erróneas, contaminación bacteriana y eventos adversos graves, incluyendo sepsis y anafilaxia.

Identificó un "vacío regulatorio" crítico en la actividad de las farmacias no residentes que envían productos a Puerto Rico desde otras jurisdicciones sin transparencia ni rendición de cuentas. Por ello, la empresa concluyó que la legislación original no debe limitarse a la solicitud de informes, sino que debe evolucionar hacia un marco jurídico robusto fundamentado en la Ley de Farmacia de Puerto Rico para cerrar estas brechas de seguridad y garantizar una supervisión efectiva por parte del Departamento de Salud.

Para atender esta problemática, Eli Lilly propuso enmiendas específicas a la Ley de Farmacia de Puerto Rico (Ley 247-2004) que transformen la medida en una estructura regulatoria completa. Las principales enmiendas propuestas por Eli Lilly son:

- Alcance Jurisdiccional (Art. 1.02): Se aclara que el propósito de la Ley de Farmacia incluye proteger la salud pública independientemente del lugar físico desde donde se dispense el medicamento, permitiendo regular fármacos que llegan a Puerto Rico vía canales interestatales o remotos.
- Nuevas Definiciones Cruciales (Art. 1.03): Se incorporan términos legales para facilitar la fiscalización, tales como "dispensación a un paciente localizado en Puerto Rico", "farmacia no residente", "evento adverso grave" y, fundamentalmente, la definición de "**medicamento compuesto de alto riesgo**" (que incluye biológicos, péptidos y productos estériles).
- Autorización Especial (Art. 5.04(f)): Se establece el requisito de una autorización previa del Secretario de Salud para que cualquier farmacia (local o no residente) pueda preparar y dispensar medicamentos de alto riesgo, exigiendo divulgación de volúmenes de producción e informes de inspección.
- Prohibiciones Específicas contra la Fabricación Ilegal: Se prohíbe explícitamente:
 - La preparación anticipada para inventario general (debe ser por receta específica).
 - El envío directo a establecimientos no autorizados como spas médicos, clínicas estéticas o centros de bienestar.
 - La distribución bajo modelos de suscripción o membresía.
 - Representar un compuesto como "terapéuticamente equivalente" a un producto aprobado por la FDA.
 - Preparar copias de medicamentos comerciales disponibles, salvo necesidad clínica documentada.
- Controles de Calidad y Trazabilidad de Ingredientes (API): Se exige que los ingredientes sean de grado farmacéutico, acompañados de certificaciones de

pureza y potencia, y manufacturados en instalaciones registradas y supervisadas por la FDA que no tengan alertas de importación o "warning letters" pendientes.

- Registro de Farmacias No Residentes (Art. 5.11-A): Crea un régimen obligatorio donde estas farmacias deben obtener un certificado de la SARSP, poseer licencia vigente en su origen, designar un agente representante en Puerto Rico y contar con acreditación de la *National Association of Boards of Pharmacy*.
- Mecanismos de Fiscalización y Pago: Prohíbe a aseguradoras, planes de salud y administradores de beneficios (PBM) pagar por medicamentos dispensados por farmacias no residentes que no estén registradas. También impide a médicos locales ordenar medicamentos de dichas entidades no autorizadas.
- Autosuficiencia Financiera (Art. 5.16): Propone destinar los ingresos recaudados por los registros de farmacias no residentes directamente a la SARSP para asegurar que el Departamento de Salud tenga los recursos humanos y materiales para ejercer la supervisión.

En resumen, Eli Lily sostuvo que las enmiendas propuestas al Proyecto del Senado 858 fortalecen significativamente el Proyecto original; proporcionan un marco legal más preciso, alinean la medida con la estructura de la Ley de Farmacias de Puerto Rico; definen las partes y productos sujetos a regulación; imponen salvaguardas significativas a los medicamentos compuestos de alto riesgo; crean un sistema de registro e informes viable para farmacias no residentes y brindan a los reguladores herramientas más eficaces de transparencia y cumplimiento. Acentuó, que estos cambios responden directamente a los riesgos documentados en el mercado de medicamentos compuestos y proporcionan a Puerto Rico un marco de salud pública más coherente y aplicable para proteger a los pacientes.

Concluyó, enfatizando que los pacientes en Puerto Rico merecen medicamentos manufacturados con ingredientes legítimos de grado farmacéutico, en condiciones seguras e higiénicas, y bajo un sistema regulatorio que garantice una rendición de cuentas efectiva por lo que es de la opinión que, con la adopción de las enmiendas propuestas, el Gobierno de Puerto Rico se acerca a este objetivo.

ASOCIACIÓN FARMACIAS DE LA COMUNIDAD DE PUERTO RICO (AFCPR)

La Distinguida Comisión de Salud tuvo la oportunidad de examinar los comentarios presentados por la **Asociación Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico (AFCPR)** los

cuales fueron suscritos por su Presidente, el Lcdo. Isaías Serrano Ramos y su Directora Ejecutiva, la Sra. Linda Ayala Bousson, presentando ciertas preocupaciones y recomendaciones sobre la pieza legislativa.

Aunque la Asociación reconoció la importancia de proteger la seguridad de los pacientes y de prevenir la preparación ilegal de medicamentos enumeró ciertos aspectos que, a su entender, deben ser evaluados cuidadosamente:

1. Posible generalización sobre la preparación de medicamentos compuestos- Expuso que la preparación de medicamentos compuestos es una práctica legítima y necesaria dentro de la farmacia cuando se realiza conforme a los estándares regulatorios y profesionales aplicables.
2. Marco regulatorio existente- Planteó que las farmacias en Puerto Rico ya están sujetas a un amplio marco regulatorio que incluye la Ley de Farmacia de Puerto Rico, reglamentos de la Junta Examinadora de Farmacia, inspecciones del Departamento de Salud y estándares técnicos profesionales aplicables.
3. Inclusión amplia de establecimientos en los informes regulatorios- Denunció que el texto podría interpretarse de forma amplia y colocar en el mismo marco estadístico o regulatorio a farmacias debidamente licenciadas Junto con establecimientos no regulados.
4. Riesgo de impacto reputacional- Sostuvo que la publicación de informes regulatorios sin contexto adecuado podría generar interpretaciones incorrectas por parte del público y afectar injustamente a farmacias que cumplen con la ley.

Por tal motivo, recomendó incluir las siguientes enmiendas en el texto del Proyecto:

1. Aclarar que la medida se enfoca en prácticas ilegales de preparación de medicamentos compuestos.
2. Diferenciar entre establecimientos regulados y no regulados en los informes.
3. Incluir la participación activa de la Junta Examinadora de Farmacia.
4. Evitar duplicidad de supervisión o cargas administrativas innecesarias para farmacias que ya cumplen con las regulaciones existentes.

La Asociación de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico concluyó reafirmando su compromiso con la seguridad del paciente y con el cumplimiento de las regulaciones aplicables a la práctica farmacéutica. Indicó coincidir en la importancia de combatir la preparación ilegal de medicamento compuestos y fortalecer los mecanismos de

supervisión cuando sea necesario, siempre y cuando se revise el Proyecto a los fines de evitar interpretaciones que puedan afectar injustamente a farmacias de comunidad que operan conforme a la Ley.

COOPHARMA

La **Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas (COOPHARMA)** remitió sus comentarios a la Ilustre Comisión de Salud mediante un Memorial Explicativo suscrito por su Director Ejecutivo, Heriberto Ortiz Martínez. En el mismo, exhibió una postura de apoyo condicionado hacia el Proyecto del Senado 858.

La organización favoreció firmemente el objetivo principal de la medida que busca elevar los niveles de transparencia y fortalecer la fiscalización de la preparación de medicamentos compuestos en Puerto Rico. Reconoció, que existe un problema creciente de preparación ilegal de estos fármacos y apoya la creación de informes bianuales por parte de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (hoy SARSP) y la Junta Examinadora de Farmacia. Para COOPHARMA, la recopilación de datos sobre licencias, inspecciones y acciones disciplinarias es una herramienta vital para identificar prácticas irregulares y proteger la salud pública.

Sin embargo, su preocupación central radica en que la redacción actual del Proyecto podría generar confusión jurídica y debilitar el marco regulatorio vigente. La organización enfatizó que, bajo la Ley de Farmacia de Puerto Rico (Ley 247-2004), la preparación de medicamentos compuestos es una función exclusiva de farmacéuticos licenciados en farmacias debidamente autorizadas. Le resulta alarmante cómo establecimientos que no son farmacias, tales como spas médicos, clínicas de bienestar, centros de estética y plataformas de telemedicina, están promocionando y administrando medicamentos compuestos, especialmente terapias tipo GLP-1 para obesidad y diabetes, sin contar con la supervisión profesional ni los controles de esterilidad y dosificación requeridos por ley.

Ante este panorama, COOPHARMA condicionó su respaldo total a que el Proyecto sea enmendado para reafirmar explícitamente que la preparación de compuestos es parte integral de la práctica de la farmacia. Advirtió, que el Proyecto menciona inspecciones a spas y clínicas, lo cual podría malinterpretarse como una autorización implícita para que dichos lugares realicen estas tareas. Por ello, sugirió que la legislación deje claro que estos

establecimientos solo pueden administrar o dispensar medicamentos si estos han sido preparados previamente por una farmacia licenciada. Asimismo, sostuvo que permitir la preparación fuera de este entorno técnico representa un riesgo crítico de contaminación microbiológica y falta de trazabilidad.

Finalmente, instó a la Comisión a que la medida no solo se limite a la publicación de informes, sino que se asignen recursos específicos para fortalecer la coordinación entre Agencias y perseguir activamente a los establecimientos que operan fuera de la Ley. Su posición defiende el rol fundamental de las farmacias de comunidad en la preparación segura de terapias individualizadas y advierte que cualquier política pública en esta materia debe armonizarse con las leyes existentes para evitar interpretaciones que pongan en peligro la seguridad de los pacientes puertorriqueños.

INDUSTRY UNIVERSITY RESEARCH CENTER, INC. (INDUNIV)

Por su parte, **Industry University Research Center, Inc. (INDUNIV)**, mediante su Memorial Explicativo suscrito por su director Ejecutivo, Iván Lugo, expresó un respaldo contundente al Proyecto, considerando que su aprobación es un paso fundamental para robustecer la seguridad de los pacientes y proteger la integridad de la cadena de suministro farmacéutica en Puerto Rico.

Como organización que promueve la colaboración entre la academia, la industria y el gobierno, INDUNIV sostuvo que la medida armoniza la regulación local con el marco legal federal, específicamente con la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y la Ley de Calidad y Seguridad de los Medicamentos (DQSA) de 2013. Para la entidad, es una prioridad de política pública el fortalecer la supervisión del "*drug compounding*", informada por evidencia científica y mejores prácticas regulatorias adoptadas en otras jurisdicciones de los Estados Unidos.

Justificó su apoyo destacando la necesidad de una autorización especial para aquellas farmacias que preparan medicamentos compuestos de alto riesgo. Enfatizó, que esta disposición garantiza que solo las instalaciones con la infraestructura adecuada, controles de esterilidad rigurosos y personal altamente capacitado puedan manejar formulaciones complejas. Es de la opinión que, al elevar estos estándares, se mitigan riesgos inherentes a la práctica, como la contaminación microbiológica o errores de dosificación, los cuales han causado incidentes graves a nivel nacional en el pasado. Además, acentuó, que el

requisito de utilizar ingredientes farmacéuticos activos (API) de grado farmacéutico y provenientes de fabricantes registrados ante la FDA es esencial para prevenir el uso de sustancias de procedencia desconocida o subestándar.

Otro pilar central en la posición de INDUNIV es la eliminación de la brecha regulatoria respecto a las farmacias no residentes que operan fuera de Puerto Rico. Respaldó la creación de un registro público obligatorio para estas farmacias, permitiendo que pacientes, proveedores de salud y aseguradoras verifiquen la legitimidad de las entidades que distribuyen medicamentos en la Isla. Sostuvo, que este modelo de supervisión, similar al de estados como Nueva York o California, promueve una trazabilidad total y evita que el mercado local sea vulnerable a prácticas de distribución no autorizadas. Planteó, que este control es vital para mantener la transparencia en un sector tan crítico para la vida humana.

Finalmente, INDUNIV subrayó que la rendición de cuentas por parte de las Agencias, a través de informes semestrales publicados por la SARSP, es una medida de transparencia moderna y necesaria. Es de la opinión que estos informes permitirán documentar hallazgos de inspecciones y acciones de cumplimiento, facilitando una supervisión basada en el riesgo. En conclusión, instó a la Comisión a emitir un informe favorable, reafirmando que el P. del S. 858 es una herramienta prudente que no solo protege la salud pública, sino que también fortalece el ecosistema de innovación y desarrollo biofarmacéutico al asegurar un entorno operativo legalmente sólido y seguro.

BIOTECHNOLOGY INNOVATION ORGANIZATION (BIO)

Examinamos también los comentarios presentados por **Biotechnology Innovation Organization (BIO)**, los cuales fueron suscritos por Primitivo J. Castro, Director, Asuntos Gubernamentales Estatales de la Región Occidental y Puerto Rico expresando su endoso a la medida. Explicó que, los miembros de BIO abarcan desde empresas emergentes de biotecnología hasta algunas de las compañías biofarmacéuticas más grandes del mundo, todas unidas por el mismo objetivo: desarrollar avances médicos y científicos que prevengan y combatan enfermedades, restauren la salud y mejoren la vida de los pacientes.

Detalló, además, que la composición y distribución ilegal de medicamentos (particularmente fármacos de alto riesgo como las terapias con agonistas del receptor

GLP-1 e inyectables estériles), se ha convertido en una amenaza significativa para la salud pública en Puerto Rico. Aseveró, que los pacientes están cada vez más expuestos a productos que pueden estar contaminados, ser de baja potencia o haber sido fabricados sin controles de esterilidad adecuados, pruebas de calidad, trazabilidad o supervisión médica.

BIO procedió a enumerar las razones por las que apoya la pieza legislativa objeto de evaluación:

- Establece una definición clara de "medicamento compuesto de alto riesgo". Al clasificar los productos estériles, de administración sistémica, biológicamente complejos y de otro tipo de alto riesgo, el proyecto de ley garantiza que las salvaguardas reforzadas se apliquen específicamente a los medicamentos que representan la mayor amenaza potencial si se componen de manera inadecuada.
- Requiere autorización especial para las farmacias que componen medicamentos de alto riesgo. Esta supervisión específica garantiza que solo las instalaciones certificadas puedan preparar dispensar productos compuestos de alto riesgo, fortaleciendo las protecciones a los pacientes y mejorando la visibilidad regulatoria.
- Exige el uso de ingredientes de grado farmacéutico y documentación de calidad adecuada. Este requisito se alinea con las prácticas de manufactura federales vigentes y previene el uso de ingredientes farmacéuticos activos (API's por sus siglas en inglés) de grado investigativo o adulterados que exponen a los pacientes a contaminantes o potencia inconsistente.
- Requiere la verificación de manufactureros certificados por la FDA. Al garantizar que los fabricantes originales estén registrados ante la FDA, libres de problemas de inspección no resueltos y no sujetos a Alertas de Importación o Cartas de Advertencia, el PS 858 refuerza la integridad de la cadena de suministro y elimina las oportunidades de que ingredientes ilícitos o inseguros ingresen al mercado.
- Establece el registro y la supervisión de farmacias no residentes. Esta disposición llena un vacío regulatorio crítico al garantizar que las farmacias ubicadas fuera de Puerto Rico, pero que envían medicamentos a la jurisdicción, cumplan con todos los estándares aplicables e informen de manera transparente sobre su actividad de composición y eventos adversos.
- Crea requisitos de informes públicos bienales y transparentes. Al exigir que la Secretaría Auxiliar para la Reglamentación de la Salud Pública (SARSP) publique los resultados de las inspecciones, violaciones, acciones de cumplimiento y

evaluaciones de los recursos regulatorios y los riesgos emergentes, el proyecto de ley mejora la rendición de cuentas y proporciona a los legisladores y partes interesadas la información necesaria para abordar de manera proactiva las amenazas a la seguridad de los pacientes.

Concluyó, indicando que el P del S. 858 proporciona a los reguladores las herramientas necesarias para garantizar la calidad de los medicamentos, proteger a los pacientes y restaurar la confianza en el sistema de salud.

NATIONAL CONSUMERS LEAGUE

La **National Consumers League (NCL)** mediante su Memorial Explicativo presentado por Nancy Glick, Directora de Políticas de Alimentos y Nutrición, expresó su apoyo a la aprobación del P. del S. 858, fundamentado en la necesidad crítica de proteger a los consumidores puertorriqueños de lo que denominan una "segunda crisis de obesidad".

Según la organización, existe un mercado explotador y poco regulado donde empresas de telemedicina, *med-spas* y otros vendedores se aprovechan de las lagunas legales para comercializar versiones compuestas de medicamentos GLP-1 (como los utilizados para la pérdida de peso) que no han sido probados ni aprobados por la FDA. Resaltó, que esta situación ha provocado un aumento alarmante en eventos adversos, incluyendo hospitalizaciones y sobredosis debido a errores de dosificación e ingredientes contaminados.

La postura de NCL se detalla en tres ejes fundamentales de protección al paciente:

- Protección de la cadena de suministro: Respaldó que el Proyecto defina claramente qué es un "medicamento compuesto de alto riesgo" y exija que las farmacias que los preparan obtengan una autorización especial del Departamento de Salud. Esto garantiza que solo los establecimientos que cumplen con estándares de esterilidad y calidad puedan operar. Además, considera acertada la obligatoriedad de usar ingredientes de grado farmacéutico que cuenten con certificados de análisis válidos y provengan de instalaciones registradas ante la FDA, evitando el uso de sustancias peligrosas o de origen incierto.
- Fiscalización de farmacias no residentes: apoya el que se fortalezca la supervisión sobre las farmacias fuera de Puerto Rico que envían medicamentos a la Isla. Estima oportuna la implementación de un sistema de registro y reporte obligatorio,

advirtiendo que, de no cumplirse, los proveedores de salud no deberían utilizar estas farmacias ni las aseguradoras reembolsar sus productos. Planteó, que esta medida busca cerrar brechas de seguridad que actualmente exponen a los pacientes a fármacos imposibles de rastrear.

- Transparencia y rendición de cuentas: Finalmente, destacó la importancia de que la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) publique informes semestrales detallados. Es de la opinión que el acceso público y gratuito a datos sobre inspecciones, violaciones y riesgos emergentes es esencial para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas.

En conjunto, la NCL ve en el P. del S. 858 una herramienta indispensable para garantizar que el derecho de los pacientes a recibir medicinas seguras y de alta calidad se cumpla efectivamente en Puerto Rico.

**OBESITY ACTION COALITION, NATIONAL CONSUMERS LEAGUE,
PARTNERSHIP FOR SAFE MEDICINES, JOHN HERTING
Y MICHAEL STEPANOVICH**

En unísono, la **Obesity Action Coalition, National Consumers League, Partnership for Safe Medicines, John Herting y Michael Stepanovich**, presentaron un escrito manifestando su respaldo firme y unánime a la pieza legislativa.

Su postura surge de una profunda preocupación por la distribución desenfrenada de medicamentos compuestos que no han sido probados y cuya calidad es desconocida. Para este grupo de expertos y defensores del paciente, la preparación ilegal de estos fármacos representa una amenaza crítica para la seguridad pública y la integridad del sistema de salud en Puerto Rico, especialmente ante el auge de medicamentos de alto riesgo como los GLP-1 para el tratamiento de la obesidad y la diabetes.

Sostuvieron que el P. del S. 858 ofrece soluciones integrales al establecer definiciones claras y requisitos de autorización especial para las farmacias que manejan compuestos de alto riesgo. Plantearon que, al exigir que solo establecimientos calificados y supervisados por el Departamento de Salud realicen estas tareas, se garantiza un control riguroso sobre la esterilidad y la dosificación. Además, subrayaron la importancia de proteger la cadena de suministro mediante el uso obligatorio de ingredientes de grado farmacéutico y procesos de verificación que eviten la entrada de sustancias adulteradas

o manufacturadas bajo prácticas inseguras que pongan en peligro la vida de los ciudadanos.

Referente a la supervisión sobre las farmacias no residentes que envían medicamentos a la isla, consideran acertada la creación de un registro obligatorio ante la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP), el cual requerirá que estas entidades informen sobre sus productos y notifiquen de inmediato cualquier evento adverso. Puntualizaron que, al prohibir que los proveedores utilicen farmacias no registradas y que las aseguradoras reembolsen sus servicios, la Ley crea un mecanismo de cumplimiento robusto que elimina los "puntos ciegos" regulatorios que actualmente dificultan la fiscalización y la respuesta ante riesgos sanitarios.

Finalmente, enfatizaron que la transparencia es esencial para restaurar la confianza en el sistema de salud puertorriqueño. Por ello, estiman oportuna la publicación de informes públicos y gratuitos que detallen los resultados de las inspecciones, las violaciones detectadas y las acciones de cumplimiento tomadas por las autoridades. En conclusión, consideran que el P. del S. 858 proporciona las herramientas necesarias para cerrar las brechas legales actuales, asegurando que los pacientes en Puerto Rico tengan acceso exclusivo a medicamentos que cumplan con los más altos estándares de seguridad, eficacia y calidad.

AMERICAN BOARD OF OBESITY MEDICINE

Recibimos, de igual forma, los comentarios de la **American Board of Obesity Medicine**, suscritos por el Dr. Adonis Saremi, diplomático certificado, quien expresó su respaldo a la medida, fundamentado en más de una década de experiencia en medicina metabólica e informática clínica.

Destacó la falta de transparencia que rodea a la fabricación masiva de medicamentos compuestos, los cuales a menudo se comercializan falsamente como soluciones personalizadas. Sostuvo que, si bien el "*compounding*" tiene una función clínica vital para pacientes con alergias o necesidades de dosificación únicas, la proliferación actual de fármacos mal elaborados, especialmente los péptidos GLP-1, representa una amenaza creciente y significativa para la seguridad del paciente.

En su exposición, destacó, que los productos preparados en farmacias 503A no están aprobados por la FDA ni están obligados a seguir las mismas normas estrictas de fabricación (cGMP) que los fabricantes regulados. Considera que esto resulta en una variabilidad peligrosa en términos de esterilidad, potencia y pureza. American Board of Obesity Medicine citó datos alarmantes de farmacovigilancia de 2026, donde los productos compuestos de GLP-1 mostraron tasas significativamente más altas de errores de preparación, contaminación y hospitalización en comparación con las versiones aprobadas por la FDA. Además, advirtió que estos compuestos suelen utilizar fuentes de ingredientes no verificadas o formas de sales no aprobadas que ponen en duda su estabilidad y equivalencia clínica.

Justificó su apoyo a la pieza legislativa subrayando su capacidad para mejorar la seguridad a través de dos ejes principales: la coordinación de los reguladores locales y la rendición de cuentas de las farmacias que envían medicamentos a la isla. Considera acertado que la Ley establezca requisitos de coordinación y el intercambio de datos entre la SARPS (antes SARAFS), la Junta Examinadora de Farmacia y el Departamento de Justicia. Añadió, que el acceso público a los hallazgos de supervisión y los informes bianuales permitirá que tanto pacientes como proveedores comprendan mejor los riesgos reales y tomen decisiones médicas más informadas.

Finalmente, la American Board of Obesity Medicine acentuó que el establecimiento de licencias para farmacias no residentes y la autorización especial para compuestos de alto riesgo son medidas de "sentido común" que protegen la salud pública. Es de la opinión que la aprobación de la pieza legislativa será un paso pivotal para asegurar que los pacientes puertorriqueños tengan acceso únicamente a medicamentos cuya seguridad y eficacia hayan sido probadas. Agregó que, fortalecer la supervisión en entornos como medical spas y clínicas de bienestar es esencial para erradicar las prácticas que aprovechan los vacíos en la Ley.

THE PARTNERSHIP FOR SAFE MEDICINE

Esta Ilustre Comisión recibió una carta de apoyo al P. del S. 858 de parte **The Partnership for Safe Medicine (PSM)** la cual fue suscrita por su Director Ejecutivo, Shabbir Safdar.

Esta organización de salud pública dedicada a la seguridad de los medicamentos recetados y a la protección de los consumidores contra fármacos falsificados, subestándar

o inseguros considera que esta legislación representa un avance significativo para la seguridad de los pacientes y es una herramienta clave para mitigar eventos de daño a la salud que ya son previsibles bajo el marco actual. Basó su respaldo en la necesidad de combatir el aumento masivo de medicamentos compuestos ilegalmente o sin necesidad médica, una tendencia que ha crecido de manera alarmante en toda la nación.

PSM destacó que, aunque las farmacias de compuestos cumplen una función vital al personalizar dosis para necesidades únicas de ciertos pacientes, en muchos casos esta práctica ha evolucionado hacia una producción en masa que carece de las salvaguardas exigidas a los fabricantes de medicamentos convencionales. Dado que la regulación farmacéutica es un esfuerzo conjunto entre las autoridades territoriales y federales, la organización entiende el P. del S. 858 es una salvaguarda localmente apropiada y necesaria para proteger a los pacientes en Puerto Rico de estas prácticas de manufactura que evaden los controles de calidad estándar.

Argumentó, que el Proyecto podría cerrar brechas críticas en la supervisión regulatoria. Resaltó, además, en la importancia de instituir informes bianuales que detallen el estado de las licencias, las inspecciones, las investigaciones y las acciones disciplinarias tomadas. Le parece correcto el requisito de realizar análisis periódicos de riesgos emergentes, lo que permitiría a los reguladores identificar y reaccionar rápidamente ante nuevas amenazas a la salud pública antes de que escalen.

Finalmente, la Partnership for Safe Medicines subrayó que el enfoque del Proyecto en combatir la publicidad engañosa es esencial para la protección del consumidor. Al abogar por una mayor transparencia y una supervisión estricta en la cadena de suministro, reafirmó que el P. del S. 858 es indispensable para asegurar que los ciudadanos de Puerto Rico reciban tratamientos seguros y legítimos. Concluyó que, al fortalecer estos mecanismos de fiscalización no solo se previenen daños físicos, sino que también se restaura la confianza en la integridad de los medicamentos que se dispensan en el sistema de salud.

LCDO. EDWIN LEÓN PÉREZ

Examinamos de igual forma, los comentarios vertidos por el **Lcdo. Edwin León Pérez**, abogado y profesor adjunto de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, quien expresó una postura de oposición al Proyecto del Senado

858. Su análisis profundiza en las contradicciones estructurales de la pieza legislativa, argumentando que existe una brecha insalvable entre los objetivos loables de la exposición de motivos y los mecanismos operativos que realmente implementa el articulado del Proyecto.

El primer punto de conflicto que identificó el Licenciado es la asimetría en el enfoque regulatorio. Sostuvo que, aunque la pieza legislativa se justifica como una herramienta para detener la preparación ilegal en lugares como spas médicos y clínicas de bienestar, el peso de la nueva regulación recae exclusivamente sobre las farmacias de composición debidamente licenciadas bajo las categorías 503A y 503B. Planteó, que resulta una contradicción de política pública pretender eliminar la ilegalidad fiscalizando con mayor rigor a los actores que ya operan dentro del marco legal estatal y federal (FDA).

Denunció como un sistema de "carpeteo" administrativo disfrazado de "monitoreo la obligación de emitir informes bianuales con datos detallados sobre inspecciones, recursos humanos y capacidades técnicas de las farmacias de comunidad, al entender que no es un ejercicio de transparencia, sino una exposición innecesaria de la propiedad intelectual y operativa de estas empresas. Puntualizó, que este nivel de escrutinio público, sin que existan determinaciones finales de incumplimiento, lacera la reputación y la buena fe de las instituciones que sirven como un eslabón esencial para pacientes con necesidades especiales.

El Lcdo. León Pérez también destacó una peligrosa ambigüedad terminológica en el proyecto, toda vez que carece de definiciones técnicas precisas para conceptos como "preparación ilegal" y "medicamentos compuestos de alto riesgo". Es de la opinión que, al agrupar en una misma categoría a las farmacias altamente reguladas con establecimientos estéticos no clínicos, el proyecto genera una distorsión del riesgo real. Sostuvo, que esta falta de claridad podría llevar a los reguladores y al público a concluir erróneamente que toda actividad de composición es intrínsecamente peligrosa o sospechosa.

En el ámbito económico, advirtió que, a nivel internacional, en los próximos años expirarán varias patentes legales que protegen la propiedad intelectual de compañías farmacéuticas, como por ejemplo, la formulación química de semaglutide, lo que implicará que dicho medicamentos podrán ser compuestos legalmente por farmacias de composición 503A y/o 503B. Argumentó, que el proyecto parece otorgar una ventaja

estratégica a las grandes farmacéuticas multinacionales al permitirles "monitorear" indirectamente a través de los informes de la SARSP qué farmacias locales tienen la capacidad técnica para producir alternativas compuestas legales. Argumentó, que esta "visión" del mercado es unilateral, ya que las operaciones de las grandes farmacéuticas no estarían sujetas a la misma transparencia bajo este proyecto de ley.

Asimismo, el Lcdo. León Pérez alertó sobre la falta de un análisis de impacto fiscal realista. Señaló, que la pieza legislativa impone responsabilidades masivas de recopilación y publicación de datos a la SARSP y a la Junta Examinadora de Farmacéuticos sin asignar ni un solo dólar de presupuesto adicional. Sobre esto, agregó, que imponer mandatos burocráticos sin recursos solo conducirá a una fiscalización ineficaz, desviando al personal de las tareas de inspección de campo para convertirlos en procesadores de datos estadísticos.

Otro aspecto de su oposición es que el Proyecto ignora las protecciones federales ya existentes. Enfatizó, que las farmacias 503A ya están sujetas a los estándares de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP 795, 797 y 800) y que la FDA posee la facultad de intervenir ante riesgos significativos, por lo tanto, considera que la medida es redundante y solo añade una capa de complejidad que podría desincentivar a las farmacias de seguir ofreciendo el servicio de compuestos, lo que finalmente afectaría el acceso de los pacientes a tratamientos personalizados.

De otra parte, expresó su preocupación por la ausencia de datos empíricos que sustenten la magnitud del problema en Puerto Rico. Arguyó, que la Exposición de Motivos del Proyecto se basa en premisas generales y no en estadísticas locales específicas que justifiquen una intervención regulatoria de tal magnitud. Es de la opinión que, legislar sobre la base de preocupaciones anecdóticas o tendencias de otros mercados sin evidencia local sólida es una práctica legislativa que puede llevar a políticas públicas erróneas y desproporcionadas.

Finalmente, el Lcdo. Edwin León Pérez subrayó que la verdadera amenaza a la salud pública no proviene de las farmacias licenciadas en la Isla, sino del mercado negro de ingredientes y medicamentos que llegan desde jurisdicciones con nula trazabilidad, como China o América Latina. Exhortó al Senado a denegar la aprobación de la medida, planteado que, si realmente se desea proteger al paciente, el enfoque debe estar en fortalecer la persecución criminal de quienes operan totalmente fuera de la Ley y no en

sofocar con burocracia a los profesionales de la farmacia que son los aliados naturales del sistema de salud.

ING. HOMAR TORRES

El **Ing. Homar Torres**, en calidad de paciente presentó sus comentarios en contra del P. del S. 858 ante la Comisión de Salud. Indicó, que su postura no nace de un interés comercial, sino de su propia experiencia como un paciente a quien la medicina tradicional desahució y que logró recuperar su calidad de vida, incluso completando eventos como el *Ironman*, gracias al uso de péptidos. Argumentó, que, bajo el pretexto de la seguridad, esta medida es en realidad una prohibición encubierta diseñada por los intereses de las grandes farmacéuticas para eliminar la competencia de tratamientos asequibles y proteger sus monopolios de patentes.

Sostuvo que, con esta medida, se está legislando desde el desconocimiento científico al clasificar erróneamente a todos los péptidos como medicamentos compuestos de alto riesgo. Ilustró, que los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos, bloques naturales de la vida que el cuerpo reconoce y recicla, a diferencia de los fármacos químicos sintéticos que a menudo dejan residuos tóxicos. Considera como una contradicción alarmante que se pretenda restringir estas moléculas naturales mientras que medicamentos tradicionales, como los anticoagulantes y los antiinflamatorios, causan miles de hospitalizaciones y muertes anuales por reacciones adversas sin enfrentar tales niveles de escrutinio.

Señaló, que las patentes de fármacos como la semaglutida (Ozempic/Wegovy) están próximas a expirar en 2026, lo que permitiría el acceso a genéricos por una fracción del costo actual. Destacó, que producir estos péptidos cuesta menos de \$10 mensuales, mientras que las farmacéuticas los venden por \$1,000 o más. Según su análisis, la industria busca usar el poder regulatorio para asfixiar a las farmacias de composición y a los suplidores externos, obligando a los pacientes a pagar precios exorbitantes o quedarse sin tratamiento.

Torres definió como un engaño terminológico por parte de la industria. Aclaró, que la mayoría de los péptidos que usan los pacientes vienen en forma liofilizada (polvo seco) y solo requieren reconstitución con agua estéril, no una composición compleja de múltiples ingredientes. Alegó, que equiparar este proceso simple con la fabricación de

mezclas farmacéuticas peligrosas es una táctica para crear una categoría artificial que justifique regulaciones onerosas e innecesarias que farmacias pequeñas no podrán cumplir.

Resaltó el contraste internacional, señalando que mientras en Puerto Rico se debate la prohibición, en Europa y Asia los péptidos se utilizan hace décadas para regenerar tejidos y revertir condiciones como la fibrosis pulmonar. Denunció, además, que la educación médica local se encuentra en etapas iniciales respecto a estas terapias y advirtió que Puerto Rico corre el riesgo de convertirse en la primera jurisdicción en criminalizar el acceso a herramientas que el propio Secretario de Salud federal, Robert F. Kennedy Jr., ha defendido para ser liberadas de restricciones impuestas por la FDA bajo presión corporativa.

Desde el punto de vista legal, Torres citó jurisprudencia federal (*Nutrition Distribution LLC v. PEP Research, LLC.*) donde los tribunales han rechazado prohibir los péptidos, estableciendo que no hay evidencia de peligro inminente para la salud pública. Argumentó, que Puerto Rico no debería legislar en la dirección opuesta al Gobierno Federal el cual está moviéndose hacia un acceso más libre a través de suplidores éticos, lo que, a su vez, está limitando a los pacientes a adquirir medicamentos solo de farmacias locales con oferta limitada y a sobreprecio.

También, cuestionó la lógica de la fiscalización propuesta, planteando la interrogante de por qué, si el problema es el envío por correo, no se fortalece la vigilancia en aduanas en lugar de imponer autorizaciones especiales a farmacias que ya cumplen con la FDA y la Junta de Farmacia. Denunció, que estas capas adicionales de burocracia están diseñadas para ser tan costosas que los suplidores de Estados Unidos simplemente dejarán de enviar productos a la Isla, dejando a miles de pacientes en un limbo médico o forzándolos al mercado negro.

Aclaró, que no se opone a la regulación racional, sino a la histeria legislativa por lo que propuso que, en lugar de prohibir, se creen licencias específicas para *med-spas* y clínicas de bienestar, garantizando que los profesionales tengan la educación y certificación necesaria. Arguyó, que la solución es facilitar que los médicos ofrezcan estos suplementos a costos razonables, no crear un monopolio que solo los adinerados puedan pagar mientras los pacientes de escasos recursos quedan condenados a fármacos menos efectivos y más tóxicos.

El Ing. Homar Torres concluyó reiterando su solicitud a rechazar la pieza legislativa objeto de evaluación en su forma actual, enmendando la misma para excluir explícitamente a los péptidos de un solo ingrediente de la categoría de alto riesgo, protegiendo así el derecho fundamental del paciente a elegir tratamientos que funcionan y salvan vidas.

LCDO. IVÁN RAMÍREZ MACAYA

Compareció ante la Honorable Comisión de Salud el **Lcdo. Iván Ramírez Macaya** expresando su oposición formal al Proyecto del Senado 858 por entender que su aprobación resultaría contraria al ordenamiento jurídico vigente, específicamente con la Ley de Farmacia de Puerto Rico (Ley 247-2004), comprometería la seguridad de los medicamentos y afectaría adversamente la salud pública, al crear excepciones indebidas al marco regulatorio de la práctica farmacéutica en Puerto Rico. Añadió, que la aprobación de este proyecto debilitaría las protecciones vigentes que aseguran que solo personal cualificado y establecimientos licenciados manejen sustancias de alto riesgo.

Enfatizó, que el manejo de medicamentos no es una tarea administrativa ordinaria, sino una función clínica que requiere inspección y trazabilidad rigurosa. Defendió el que la Ley actual ya provee los controles necesarios para asegurar la calidad de los fármacos por lo que advirtió que el P. del S. 858 introduce ambigüedades que podrían debilitar la fiscalización estatal. Su preocupación principal es que se desplace la autoridad del farmacéutico hacia entornos que no cuentan con la capacitación técnica ni el equipo necesario para garantizar la seguridad del paciente.

Un punto medular de su preocupación es la apertura que el Proyecto otorga a establecimientos como spas médicos y clínicas de bienestar para participar en el manejo de medicamentos preparados. Alertó, que estos lugares operan fuera del marco de licencias de farmacia, lo que significa que no están sujetos a las mismas auditorías ni a los protocolos de almacenamiento exigidos a las farmacias de comunidad. Argumentó que, al permitir que estos centros administren sustancias sin controles claros de adquisición, el Proyecto crea un vacío legal donde podrían proliferar medicamentos de origen desconocido o desviados del mercado legítimo.

Desde una perspectiva técnica, el Lcdo. Ramirez Macaya resaltó que la pieza legislativa objeto de evaluación falla al no exigir el cumplimiento obligatorio con los estándares

internacionales de los Estados Unidos, específicamente las normas USP 795, 797 y 800. Enfatizó, que estas directrices son fundamentales para prevenir la contaminación microbiológica en medicamentos estériles y para el manejo seguro de fármacos peligrosos. Además, puntualizó que, eximir a ciertos establecimientos de estas normas técnicas es una negligencia regulatoria que expone a los ciudadanos a riesgos de infecciones graves o toxicidad por una manipulación inadecuada.

El Licenciado advirtió que la ausencia de controles de trazabilidad facilita la entrada de productos adulterados o subestándar en la cadena de salud. Esbozó, que, sin una supervisión directa y centralizada por parte de la Junta Examinadora de Farmacia, resulta imposible verificar la procedencia de los ingredientes utilizados en las preparaciones que se ofrecen en clínicas no reguladas. Es de la opinión que la salud pública no puede depender de comercios que podrían priorizar el lucro sobre el rigor clínico, especialmente cuando se manejan sustancias que tienen efectos profundos en el organismo.

En conclusión, el Lcdo. Iván Ramírez Macaya instó a la Comisión de Salud a no aprobar el P. del S. 858, argumentando que la solución a la preparación ilegal no debe ser el debilitamiento del sistema regulatorio oficial. Propuso que cualquier acción legislativa debe reafirmar la autoridad de la Ley 247-2004 y evitar la creación de categorías paralelas de establecimientos con menores exigencias legales. Concluyó, realizando un llamado a proteger al medicamento como un bien de alto riesgo que solo debe ser gestionado dentro del entorno profesional y fiscalizado de la farmacia.

VISTA PÚBLICA SOBRE EL P. DEL S. 858

La Vista Pública sobre el P. del S. 858 se llevó a cabo el 17 de marzo de 2026 mediante un panel conformado por el Departamento de Salud de Puerto Rico, representado por su Sub-Secretario, el Luis N. Olmedo Morales; el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico, representado por la Lcda. Paula D. Espada, Presidenta; la Asociación de la Industria Farmacéutica de Puerto Rico, representada por el Lcdo. Nestor Ortiz, Representante en Asuntos Gubernamentales, y Eli Lilly and Company, representada por la Lcda. Eunice Candelaria, Asesora en Asuntos Gubernamentales.

Todos los deponentes leyeron sus respectivos Memoriales Explicativos. Eli Lilly, en específico, también presentó ante la Comisión un borrador de Entirillado Electrónico proponiendo enmiendas sustanciales que atienden las preocupaciones indicadas por

el Departamento de Salud en sus comentarios.

La Senadora Migdalia Padilla Arvelo tuvo una intervención donde exteriorizó que le parecen muy buenas las enmiendas presentadas por Eli Lily. Afirmó estar a favor de la aprobación de la medida. No obstante, siendo la Presienta de la Comisión de Hacienda trajo la preocupación del impacto económico que pueda acarrear la pieza legislativa por lo que exhortó al Departamento de salud a evaluar el potencial impacto económico del Proyecto. Finalmente, indicó estar de acuerdo en atender la situación, toda vez que no pueden continuar mezclando medicamentos personas no autorizadas ni competentes.

Continuó la Vista con la discusión y el intercambio de preguntas y respuestas el cual se llevó a cabo a todo el panel de manera simultánea. Le fue informado a la Comisión lo siguiente:

1. Ante preguntas del Senador Carmelo Ríos, Eli Lily indicó haberle enviado recientemente las enmiendas propuestas al Secretario del Departamento de Salud. Enfatizó que lo que se quiso buscar con estas enmiendas fue atender en un 100% las preocupaciones presentadas por el Departamento de Salud para hacer viable la medida.
2. El autor de la medida expresó que a 100 metros de su casa hay una farmacia de *compound* y en Lomas Verdes en Bayamón hay otra. Sostuvo, que el sistema de salud ha evolucionado, que se toma una decisión informada evaluando si el beneficio es mayor que el riesgo.
3. Denunció que actualmente hay personas inyectando botox y poniendo sueros en su casa sin estar adiestrados por lo que él está pensando, como legislador, en cómo solucionar el problema. Aseveró que la excusa para no atenderlo no puede ser el factor económico porque debemos preguntarnos cuánto costaría el no hacer nada.
4. Al igual que la Senadora Padilla Arvelo, manifestó que las enmiendas propuestas por Eli Lily atienden las preocupaciones presentadas contra la medida. Informó que el jueves tiene una conferencia de prensa sobre el tema para crear *awarness*.
5. Indicó que, en uno de los memoriales se menciona la resistencia al término “spa médico”, asunto que se discutió en la Vista celebrada durante la mañana por la Comisión. A tales fines, pregunto, ¿qué es un spa médico? El Colegio de

Farmacéuticos adujo que la palabra médico no debe existir nunca con spa. Por su parte, PIA mencionó que ya está regulado lo que es una facilidad médica y lo que es un spa. Agregó, que lo importante no es la palabra sino lo que se hace en el lugar.

6. El Sub-Secretario del Departamento de Salud, expresó que él es un fisiatra y tiene terapistas físicos en su oficina que dan masajes, pero no por eso se va a promocionar como una facilidad de ofrecer masajes.
7. Al Presidente de la Comisión le preocupa las facilidades que están operando sin licencia porque ahí es donde el Departamento de Salud no tiene jurisdicción.
8. Plasmó también la interrogante de quien en el Departamento de Salud podría evaluar los datos que se recopilen, y que se requieran documentos sin ningún fin. A lo que el Departamento de Salud respondió que la Agencia puede evaluarlos, a través de la División de Planificación, la cual tiene el *expertise* y el personal preparado y la cualificación necesaria para evaluar ese tipo de datos. El Presidente le requirió incluir en el Memorial Explicativo enmendado los detalles.
9. Se unió al panel de deponentes la Licenciada Dina Martínez quien preside la División de Farmacias de la Comunidad, pero también tiene una farmacia *compounding*. Declaró que le parecieron increíbles las enmiendas propuestas por Eli Lily. Y exhortó al Senado a proveerle las herramientas para que se controle la crisis.
10. Mencionó que la mayoría de los medicamentos *compounding* no se trabajan en Puerto Rico. Añadió, que las farmacias 503B son inspeccionadas 1 vez al año por la FDA si son farmacias estériles, de las cuales solo hay 2 o 3 en Puerto Rico.
11. Reveló que las farmacias no pueden hacer *compounding* si no son FDA *approved*. Deben tener un *master formulation*.
12. Recalcó que los informes que se van a rendir les cuestan a las farmacias y a los laboratorios también. Eso lo costean ellos porque las aseguradoras no pagan.
13. Ante preguntas del Senador, explicó que en Puerto Rico no se regula cuando el paciente manda a buscar medicamentos a Estados Unidos. La deponente añadió que, incluso mandan a buscar medicamentos para rebajar a Colombia y nadie regula, ni si quiera aduna. A tales fines, peticionó que los medicamentos que los pacientes manden a buscar se evalúen.
14. La Licenciada Dina Martínez ofreció como ejemplo *Tirzepatide* que no viene para mezclarse con B12 ni B6 porque la molécula se afecta, incluso, puede llegar a causar ceguera o celulitis, entre otros.

15. El Presidente de la Comisión explicó que, en la Vista celebrada en horas de la mañana, se presentó evidencia de productos que se entregan en los centros comerciales.
16. Sobre la celebración de una campaña educativa, el Sub-Secretario del Departamento de Salud indicó que debemos comenzar por educar a la ciudadanía porque no tenemos control de los medicamentos que están llegando, desconocemos que parámetros utilizaron para preparar esos medicamentos.
17. El Presidente de la Comisión recalcó la importancia de la posición institucional del Departamento de Salud, exhortó que sea específico de manera que se pueda poner a la Comisión de Salud en posición de rendir un Informe Positivo sobre el Proyecto.
18. La Licenciada Dina Martínez enfatizó que, la medida no debería traer un costo adicional a las farmacias.
19. Eli Lily, por su parte, aclaró que, en cuanto al asunto del comercio interestatal, no debe haber obstrucción porque ya ha sido atendido en 40 Estados y no ha prevalecido el argumento. Agregó, que la Ley PROMESA tiene ciertas excepciones, como los son asuntos que trascienden el beneficio general como es este caso. Recomendó al Departamento de Salud sentarse con la Junta de Supervisión Fiscal con el propósito de solicitar un aumento para el registro. Además, sugirió que aquellos que interesen vender en Puerto Rico paguen.
20. El Presidente de la Comisión planteó su preocupación en cuanto al impacto presupuestario del registro. Narró que en el 2019 la legislatura trabajó el asunto de los PBM y la Junta de Supervisión Fiscal paralizó la implementación de la Ley por un alegado impacto de 25 millones, cuando los estudios revelan que no llegan ni a 2 millones el costo. Denunció que hoy en día, Puerto Rico no tiene regulación a los PBM por alguien que dijo esa mentira. Sostuvo, que el Gobierno de Puerto Rico ha sido tímido atendiendo los PBM. Acentuó, que las farmacias estarían mejor con regulación de los PBM.
21. Finalmente, el Presidente de la Comisión manifestó coincidir con Eli Lily en que la Junta de Supervisión Fiscal va a revisar la medida y puede paralizarla.

Previo a concluir la Vista, el Presidente de la Comisión le requirió al Departamento de Salud a presentar un memorial explicativo enmendado tomando en consideración las propuestas presentadas por el Eli Lily en el Borrador de Entirillado Electrónico entregado y discutido durante la Vista. Su respuesta fue detallada previamente en el Informe.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico certifica que **el P. del S. 858** no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

En consonancia con el espíritu que informa la Exposición de Motivos del **Proyecto del Senado 858**, la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizó un examen exhaustivo de los memoriales sometidos por Agencias Gubernamentales, Profesionales de la Salud, y Participación Ciudadana.

Del análisis integral del expediente legislativo surge la aprobación del Proyecto del Senado 858 responde a una necesidad urgente y apremiante de salud pública en Puerto Rico: la fiscalización de la preparación ilegal de medicamentos compuestos. La medida surge como un mecanismo de defensa ante el aumento alarmante de fármacos producidos sin supervisión que han proliferado en entornos no regulados como spas médicos y clínicas de bienestar. Estos establecimientos operan actualmente en un vacío legal que expone a los ciudadanos a riesgos de contaminación y dosificaciones erróneas que, según datos citados por entidades como Eli Lilly, duplican la tasa de hospitalización frente a medicamentos aprobados.

No obstante, el análisis de las posturas de diversos sectores revela una tensión evidente entre la necesidad de regulación y el temor a la sobrerregulación o el monopolio. Mientras que organizaciones de pacientes y la industria farmacéutica tradicional ven en este proyecto una defensa necesaria contra la preparación ilegal, otros sectores, como las farmacias de comunidad y defensores del acceso a terapias alternativas, advierten sobre el peligro de asfixiar a los pequeños proveedores con cargas burocráticas excesivas.

El consenso entre los proponentes, como la Asociación de la Industria Farmacéutica (PIA) e INDUNIV, subraya que la legislación no busca prohibir la preparación legítima de medicamentos, sino transformarla en una práctica estrictamente controlada. La obligatoriedad de utilizar ingredientes de grado farmacéutico (API) con procedencia verificada ante la FDA es una salvaguarda técnica vital. Esta exigencia eleva el estándar

de calidad en la Isla, asegurando que Puerto Rico no sea un mercado receptor de sustancias subestándar provenientes de jurisdicciones extranjeras sin fiscalización. Mientras que el Colegio de Farmacéuticos fue enfático en su oposición a que establecimientos no farmacéuticos puedan dispensar medicamentos.

Por su parte, el Departamento de Salud, inicialmente presentó preocupaciones jurisdiccionales y fiscales, pero armonizó su posición tras la incorporación de enmiendas sustanciales en el Entirillado Electrónico. Al integrar la regulación dentro de la Ley de Farmacia (Ley 247-2004), se evitó la duplicidad normativa y se clarificó que la Oficina de Planificación y Desarrollo (OPD) posee la pericia necesaria para evaluar los datos recopilados, garantizando que la ley sea ejecutable y no meramente burocrática

Por otro lado, la medida aborda el desafío del comercio interestatal y las farmacias no residentes. Al requerir un registro obligatorio con el propósito de permitir a las autoridades regulatorias identificar, evaluar y supervisar de manera más efectiva estas operaciones extraterritoriales con impacto directo en la salud pública local. Este control de trazabilidad es fundamental para detener la entrada de productos falsificados y garantizar que cualquier entidad que sirva a pacientes en Puerto Rico, independientemente de su ubicación física, rinda cuentas ante las autoridades locales.

Es importante reconocer las voces críticas, como la del Lcdo. Edwin León Pérez y el Ing. Homar Torres, cuyas ponencias alertaron sobre posibles efectos secundarios de la Ley, como la sobrerregulación de farmacias locales cumplidoras o el impacto en el acceso a terapias asequibles ante la expiración de patentes. Sus argumentos sirvieron para refinar la medida, buscando que el enfoque se mantenga en la persecución de la preparación no autorizada, y no en imponer mayores requisitos a la farmacia de comunidad que cumple con los rigores de la Ley.

Además, se acogieron las sugerencias de definir ciertos términos medulares tales como: "dispensación a paciente localizado en Puerto Rico", "evento adverso", "evento adverso grave", "farmacia no residente", "Ingrediente farmacéutico activo", "facilidad que fabrica un ingrediente farmacéutico activo" y "medicamento compuesto de alto riesgo". De igual forma, se eliminó el lenguaje que imponía al Departamento de Salud funciones de supervisión de publicidad que corresponden al DACO. Asimismo, se refinó la figura del farmacéutico responsable para asegurar que este profesional sea el contacto directo para

la notificación de eventos adversos, cumpliendo así con las exigencias técnicas de la SARSP.

De otra parte, se incluyeron enmiendas adicionales buscando fortalecer la protección de los pacientes puertorriqueños mediante una supervisión más efectiva de farmacias no residentes (fuera de la isla y por lo tanto no reguladas) y de establecimientos no regulados que participan en la promoción, coordinación, dispensación o administración de medicamentos compuestos, sin imponer cargas regulatorias adicionales a las farmacias que están localizadas físicamente en Puerto Rico y ya son reguladas por la legislación vigente.

Actualmente, las farmacias localizadas físicamente en Puerto Rico están debidamente licenciadas por las agencias gubernamentales correspondientes y están sujetas a un marco regulatorio integral bajo la Ley 247-2004; por ejemplo: la supervisión del Departamento de Salud, la Junta Examinadora de Farmacia y los estándares USP aplicables. Estas farmacias son inspeccionadas, licenciadas y fiscalizadas localmente, por lo que somos de la opinión que no existe la necesidad de imponer permisos, autorizaciones especiales o requisitos de reporte duplicados que limiten la producción local y su capacidad de atender las necesidades de los pacientes puertorriqueños.

Estas enmiendas específicas persiguen los siguientes objetivos principales:

- Concentrar la nueva supervisión regulatoria en farmacias no residentes (fuera de PR) que envían o dispensan medicamentos a pacientes localizados en Puerto Rico.
- Atender vacíos regulatorios relacionados con spas médicos, clínicas de bienestar y otros establecimientos no regulados que manejan o facilitan el acceso a medicamentos compuestos fuera del marco regulatorio farmacéutico tradicional.
- Evitar la duplicidad regulatoria sobre farmacias localizadas físicamente en Puerto Rico 503A que ya cumplen con los requisitos establecidos por la Ley de Farmacia de Puerto Rico y los estándares federales y profesionales aplicables.

Las mismas requieren que las farmacias no residentes (fuera de PR) se registren ante las autoridades de Puerto Rico, designen un representante local, divulguen historial disciplinario relevante y demuestren cumplimiento con estándares regulatorios equivalentes o superiores a los exigidos a las farmacias establecidas en Puerto Rico.

En síntesis, las enmiendas mantienen el objetivo de proteger la salud pública, pero orientan el proyecto hacia los sectores donde existen vacíos de supervisión: las farmacias no residentes y los establecimientos no regulados. A la vez, reconocen expresamente que las farmacias localizadas físicamente en Puerto Rico ya están reguladas bajo la Ley 247-2004 y no deben ser objeto de una segunda capa regulatoria que afecta el acceso de los pacientes puertorriqueños a medicamentos compuestos preparados localmente al amparo de la reglamentación vigente.

En conclusión, el **P. del S. 858** unifica las preocupaciones de la industria biotecnológica, las farmacias, los profesionales de la salud y las agencias reguladoras, dotando a Puerto Rico de un marco legal robusto que protege la salud de nuestra ciudadanía. La implementación enmiendas garantiza que el sistema de salud recupere la confianza pública, proveyendo herramientas reales para erradicar los puntos ciegos regulatorios y asegurar que cada medicamento dispensado en la Isla sea seguro, efectivo y de alta calidad.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, luego de la consideración correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su **Segundo Informe Positivo** sobre el **P. del S. 858**, recomendando su aprobación con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,

Juan Oscar Morales Rodríguez

Presidente

Comisión de Salud